

# Status neurologique

## Tests de force :

- ✓ **Coiffe rotateurs** : contrer une rotation externe bras **G/D** en poussant l'avant-bras médialement
- ✓ **Deltoïde** : contrer l'abduction bras **G/D** en le poussant médialement, patients assis
- ✓ **Biceps/triceps** : contrer une flexion **G/D** puis extension G/D de l'avant-bras en le poussant vers le bas/haut, avant-bras à angle droit
- ✓ **Fléchisseurs/extenseurs poignet** : contrer une flexion/extension du poignet **G/D** en poussant vers le bas/haut le poing fermé du patient
- ✓ **Extenseurs doigts** : contrer une extension doigts **G/D** en poussant vers le bas les doigts, main en pronation et extension
- ✓ **Fléchisseurs doigts** : contrer une flexion doigts **G/D**, placer l'index et majeur sur le creux de la main, demander au patient de serrer le poing et exercer une traction opposée
- ✓ **Interosseux/ court abducteur 5** : contrer une abduction doigts **G/D** en exerçant une adduction, main en pronation avec doigts écartés
- ✓ **Adducteur/court abducteur 1** : contrer une opposition (adduction + flexion) **G/D**, le patient essaye de toucher son petit doigt avec son pouce. Exerçer une force contre son pouce, main en supination
  
- ✓ **Ilio-Psoas/grand fessier** : contrer une flexion **G/D** de la cuisse puis extension G/D (assis impossible) en appuyant sous/sur cuisse
- ✓ **Quadriceps** : contrer une extension de la jambe **G/D** en maintenant le genou et en appuyant sur la jambe
- ✓ **Ischio-jambiers** : contrer une flexion de la jambe **G/D** en maintenant le genou et en appuyant sous la jambe, demander au patient d'écraser la main (si patient couché, demander de résister à étirement jambe, genou fléchi)
- ✓ **Gastrocnémien** (jambe étendue), **soléaire/tibial antérieur** : contrer flexion **G/D** puis extension en appuyant sous/sur le pied
- ✓ **Fléchisseurs/extenseurs orteils** : contrer flexion **G/D** puis extension en appuyant sur/sous le pied

## Tests fonctionnels : *Apprécier la sévérité des déficits*

- ✓ **Regarder position debout** pieds rapprochés, bras tendus : danse tendons indique ataxie (proprioceptive yeux fermés, Roomberg +/-cérébelleuse si fermés et ouverts, Roomberg -)
- ✓ **Regarder marche** : ataxie cinétique
- ✓ **Marche sur pointe pieds/talons sur ligne** : si déséquilibre alors ataxie
- ✓ **S'accroupir et se relever** : si usage de mains parésie proximale (signe Gowers)
- ✓ **Tenir sur une jambe G/D** : si bassin tombe parésie moyen fessier (signe Trendelenburg)
- ✓ **Elever les bras au-dessus de la tête**
- ✓ **Epreuve bras tendus** : tendre les bras
- ✓ **Couché, relever le buste**
- ✓ **Maintenir (couché) jambes fléchies** (sur le dos Mingazzini/ventre Barré)

*Cotation force 0-5 : 0 absence contraction/1 absence mouvement/2 mouvement réduit*

**3 mouvement, maintien contre pesanteur/4-5 mouvement contre opposition**

- *Faire une fois sans puis avec application de force*
- *Toujours stabiliser autres articulations*
- *Patient assis/couché*

**Réflexes :** (côté droite du lit pour tous les réflexes)

- ✓ **Brachio-radial G/D C6 :** tenir ses pouces dans la main (permet de relâcher les membres), taper en arrière du processus styloïde du radius (enlever la montre)
- ✓ **Biceps G/D C5 :** pour chercher le tendon demander au patient de contracter le biceps, poser les mains sur les genoux/bassin (couché) en position semi-fléchis (les agonistes et antagonistes ne doivent pas être trop contractés)
- ✓ **Triceps G/D C7 :** laisser pendre le bras latéralement et soutenir l'avant-bras, taper en arrière de l'olécrane
- ✓ **Rotulien G/D L3-4:** laisser la jambe pendre, taper en dessous de la rotule (si couché soutenir le genou)
- ✓ **Achilléen G/D S1 :** allonger le patient, incliner la jambe et le pied en rotation externe, genou fléchi, tenir le pied légèrement par le dessous, le tirer vers le haut et taper sur tendon achille
- ✓ **Babinski G/D L4-S1 (pointe douloureuse) :** Appuyer fort le long postéro-latéral du pied puis remonter au gros orteil, en cas extension de l'orteil atteinte pyramidale (pathologie)
- ✓ **Réflexe abdominal G/D T6-12:** Tracer les quatre branches d'un X centré au nombril en effectuant la manœuvre dans un sens du cadran (induit contraction abdominaux)

*Cotation 0-4 : > 2 atteinte pyramidale, < 2 atteinte périphérique*

- *Manœuvres de facilitation : serrer mâchoire (m. sup.)/tirer sur ses mains (Jendrassik/m. inf.)*
- *Effectuer 2-3 fois chaque côté (mm. relâchés)*
- *Mettre les doigts au lieu de la percussion*
- *Etre à la droite du patient sauf pour l'Achilléen*
- *Spasticité se manifeste par une extension spatiale de la zone réflexogène*

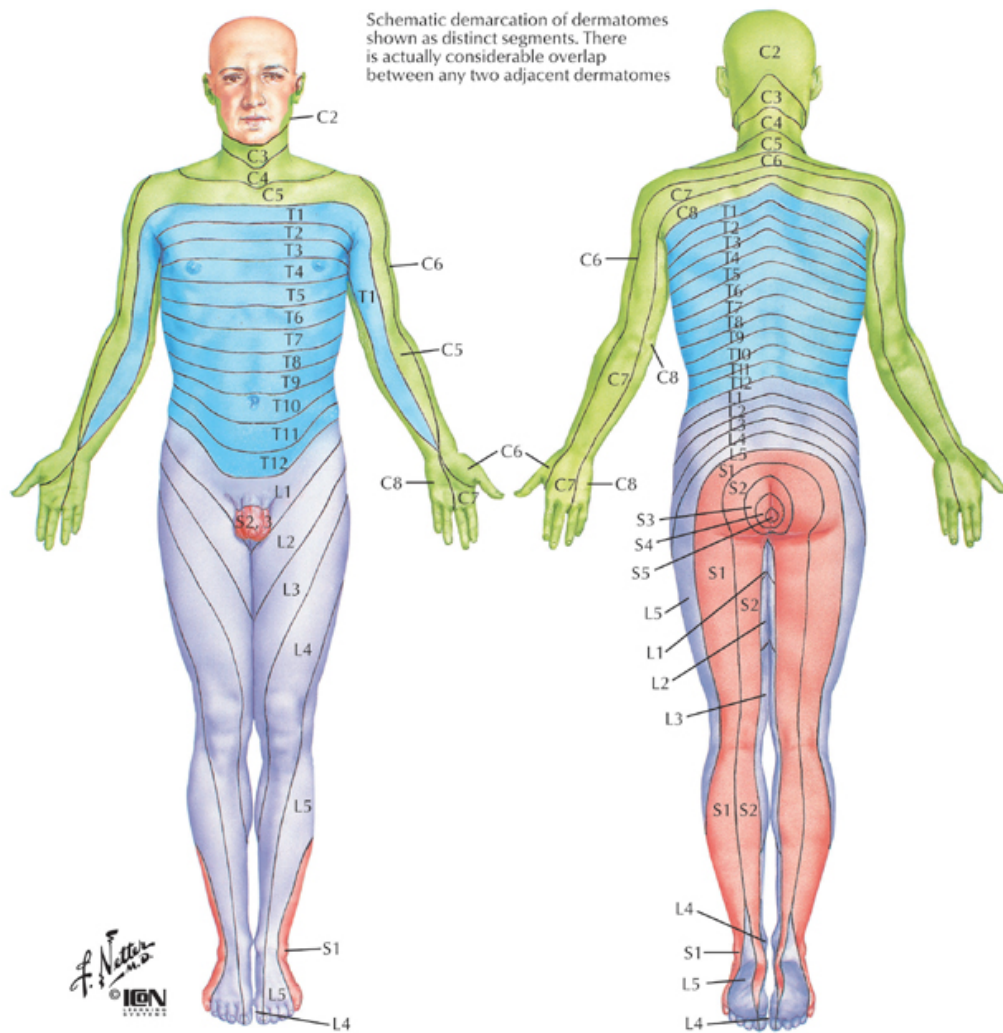
**Sensibilité :**

- ✓ **Piquer-toucher :** prendre un coton tige cassé en deux, et tester la différence de sensibilité entre la pointe/bout doux G/D en remontant depuis deuxième doigt/orteil (test base inguinale)

*Palper de manière grossière le membre avant de passer au test avant d'identifier des zones grossières*

- ✓ **Vibration :** faire vibrer un diapason (*le grand avec les indicateurs*), appliqué contre os (phalange, styloïdes, olécrane, épaule, tibia, cheville) en remontant le long des dermatomes,  
A. *montrer au patient sur le sternum*  
B. *effectuer le test en atténuant la vibration (remonter le doigt le long diapason) et demander arrêt du signal*
- ✓ **Proprioception :** déplacer les articulations vers le haut ou vers le bas en remontant le long des dermatomes, le patient devra indiquer le mouvement (yeux fermés)

*Prendre le membre latéralement pour que la pression ne fausse pas les résultats*



#### Levels of principal dermatomes

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| C5       | Clavicles                    |
| C5, 6, 7 | Lateral parts of upper limbs |
| C8, T1   | Medial sides of upper limbs  |
| C6       | Thumb                        |
| C6, 7, 8 | Hand                         |
| C8       | Ring and little fingers      |
| T4       | Level of nipples             |

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| T10         | Level of umbilicus                          |
| T12         | Inguinal or groin regions                   |
| L1, 2, 3, 4 | Anterior and inner surfaces of lower limbs  |
| L4, 5, S1   | Foot                                        |
| L4          | Medial side of great toe                    |
| S1, 2, L5   | Posterior and outer surfaces of lower limbs |
| S1          | Lateral margin of foot and little toe       |
| S2, 3, 4    | Perineum                                    |

*ECOS : si sensation distale, ne pas remonter*

*Points essentiels :*

Mamelon T4  
 Ombilic T10  
 Thénar C6  
 Hypothénar C8  
 Genou L4  
 Dos pied L5, S1  
 Plante pied L4, L5, S1